

SAZONALIDADE DE AGRAVOS NEGLIGENCIADOS EM SAÚDE E ATENDIMENTOS À INDÍGENAS DE MATO GROSSO DO SUL

SEASONALITY OF NEGLECTED HEALTH PROBLEMS AND CARE FOR INDIGENOUS PEOPLE IN MATO GROSSO DO SUL

ESTACIONALIDAD DE LOS PROBLEMAS DE SALUD DESATENDIDOS Y LA ATENCIÓN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN MATO GROSSO DO SUL

Vagner Ferreira do Nascimento¹ (<https://orcid.org/0000-0002-3355-163X>)Stefan Vilges de Oliveira² (<https://orcid.org/0000-0002-5493-2765>)Gerson Luiz Marinho³ (<https://orcid.org/0000-0002-2430-3896>)Maristela Santini Martins⁴ (<https://orcid.org/0000-0002-0730-3923>)Luciano Garcia Lourenção⁵ (<https://orcid.org/0000-0002-1240-4702>)**Descritores**

Povos indígenas; Vulnerabilidade em saúde; Atenção primária à saúde; Saúde de populações indígenas; Processo de trabalho em saúde

Descriptors

Indigenous peoples; Health vulnerability; Primary health care; Health of indigenous peoples; Healthcare work process

Descriptores

Pueblos indígenas; Vulnerabilidad en salud; Atención primaria de salud; Salud de poblaciones indígenas; Proceso de trabajo en salud

Submetido

20 de junho de 2025

Aceito

09 de julho de 2025

Conflitos de interesse:

nada a declarar.

Autor correspondente:

Vagner Ferreira do Nascimento
E-mail: vagnernascimento@unemat.br

Editor Associado (Avaliação pelos pares):

Carlos Leonardo Figueiredo Cunha
(<https://orcid.org/0000-0002-1891-4201>)
Departamento de Saúde Pública,
Universidade Federal do Maranhão, São
Luis, MA, Brasil

RESUMO

Objetivo: Avaliar a sazonalidade de agravos negligenciados em saúde e o atendimento a indígenas no estado de Mato Grosso do Sul, com o intuito de subsidiar o planejamento de estratégias de cuidado em enfermagem.

Métodos: Estudo ecológico, descritivo e quantitativo, referente ao período de 2022 a 2024, diretamente em bancos de dados do Ministério da Saúde. Para a análise, aplicou-se estatística descritiva, com uso do TabWin para apresentação dos mapas.

Resultados: Durante o período, no mês de março destacou a febre de chikungunya (25,3%) e em abril, a dengue (16,3%). Os meses com menor número de casos (julho a setembro) mantiveram uma média de atendimentos semelhante a outros períodos. Em 2024, observou-se crescimento importante nos atendimentos realizados pelos profissionais (enfermeiro, médico e odontólogo), e queda nos atendimentos dos Agentes Indígenas de Saúde ($\pm 3,84$), psicólogos ($\pm 0,06$) e assistentes sociais ($\pm 0,02$).

Conclusão: A sazonalidade dos agravos não influenciou o volume de atendimentos, sugerindo que a atuação profissional ocorre predominantemente em dinâmica linear, podendo ser um risco diante de surtos epidêmicos.

ABSTRACT

Objective: To assess the seasonality of neglected health problems and care for indigenous people in the state of Mato Grosso do Sul, with the aim of supporting the planning of nursing care strategies.

Methods: Ecological, descriptive and quantitative study, covering the period from 2022 to 2024, directly from databases of the Ministry of Health. For the analysis, descriptive statistics were applied, using TabWin to present the maps.

Results: During the period, chikungunya fever stood out in March (25.3%) and dengue fever in April (16.3%). The months with the lowest number of cases (July to September) maintained an average number of visits similar to other periods. In 2024, there was a significant increase in the number of visits provided by professionals (nurses, doctors and dentists), and a decrease in the number of visits provided by Indigenous Health Agents (± 3.84), psychologists (± 0.06) and social workers (± 0.02).

Conclusion: The seasonality of the illnesses did not influence the volume of care provided, suggesting that professional activity occurs predominantly in linear dynamics, which may be a risk in the face of epidemic outbreaks.

RESUMEN

Objetivo: Evaluar la estacionalidad de los problemas de salud y cuidados de las personas indígenas residentes en aldeas del estado de Mato Grosso do Sul, con el objetivo de subsidiar la planificación de estrategias de atención de enfermería.

Métodos: Estudio ecológico, descriptivo y cuantitativo, que abarca el período 2022-2024, basado directamente en las bases de datos del Ministerio de Salud. Para el análisis, se aplicó estadística descriptiva, utilizando TabWin para la presentación de los mapas.

Resultados: Durante el período, la fiebre chikunguña se destacó en marzo (25,3%) y el dengue en abril (16,3%). Los meses con menor número de casos (julio a septiembre) mantuvieron un promedio de consultas similar al de otros períodos. En 2024, se observó un aumento significativo en el número de consultas de profesionales (enfermeras, médicos y dentistas), y una disminución en el número de consultas de Agentes de Salud Indígenas ($\pm 3,84$), psicólogos ($\pm 0,06$) y trabajadores sociales ($\pm 0,02$).

Conclusión: La estacionalidad de las enfermedades no influyó en el volumen de atención prestada, lo que sugiere que la actividad profesional ocurre predominantemente en una dinámica lineal, lo que puede ser un riesgo ante brotes epidémicos.

¹ Faculdade Indígena Intercultural, Universidade do Estado de Mato Grosso, Barra do Bugres, MT, Brasil.

² Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil.

³ Escola Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

⁴ Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

⁵ Ministério da Previdência Social, Brasília, DF, Brasil.

Como citar:

Nascimento VF, Oliveira SV, Marinho GL, Martins MS, Lourenção LG. Sazonalidade de agravos negligenciados em saúde e atendimentos à indígenas de Mato Grosso do Sul. *Enferm Foco*. 2025;16(Supl 1):e-202502SUPL1.

DOI: <https://doi.org/10.21675/2357-707X.2025.v16.e-202502SUPL1>

INTRODUÇÃO

No Brasil, há 811.342 indígenas distribuídos em 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), com exceção do estado do Rio Grande do Norte. No Centro-Oeste, o estado de Mato Grosso do Sul possui a maior população, 84.628 indígenas.⁽¹⁾

Grande parte desses indígenas vivem a incerteza sobre suas moradias e condições de vida, dada às disputas frequentes com fazendeiros, que entre invasões, violências e assassinatos, desmatam, contaminam rios com agrotóxicos e aumentam as distâncias da legitimação de seus direitos.⁽²⁻⁴⁾

Nesse contexto de conflitos sociais prosperam agravos relacionados aos Determinantes Sociais da Saúde (DSS), tendo destaque aqueles ligados ao saneamento básico precário, a insegurança alimentar e nutricional.^(5,6) Muitos destes agravos em saúde possuem ocorrências e evoluções com estreita relação ao quantitativo e à qualificação da força de trabalho no território indígena,⁽⁷⁾ envolvendo, entre outros aspectos, planejamento, organização, compromisso e alocação adequada de recursos.

Desde 1999, ficou estabelecido em Lei que a União, com seus recursos próprios, financiaria o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), porém, esta permanece enfrentando desafios na manutenção de seu orçamento, com quedas importantes e contingenciamento do orçamento, principalmente no período de 2019 e 2022.⁽⁸⁾ Nesse aspecto, uma dificuldade percebida mais diretamente pelos DSEIs é a distribuição desigual dos recursos federais, que nem sempre seguem critérios bem definidos, considerando as especificidades territoriais, demográficas e epidemiológicas em saúde.

Em 2022, Mato Grosso do Sul foi o segundo DSEI do país com recebimento do maior volume de recursos, mas o 29º em recurso per capita. Essa grande disparidade, não ocorre em outros DSEIs de estados vizinhos, como em Mato Grosso, e isso, de alguma forma, pode estar refletindo na redução ou dificuldade no alcance de bons indicadores em saúde.⁽⁹⁾ Outra característica deste estado, são reservas indígenas próximas dos centros urbanos e grupos étnicos cada vez mais presentes nas cidades,⁽⁴⁾ vivendo, na maioria dos casos, em condições de pobreza e padecimento do seu bem-viver.⁽¹⁰⁾

Esse cenário intensifica a preocupação das autoridades, pois antigos problemas da saúde indígena persistem, enquanto outros, como o alcoolismo, o suicídio, o câncer e as doenças infecciosas, se multiplicam. Apesar do reconhecimento dessa realidade epidemiológica, os dados ainda são subestimados, mesmo em relação a agravos amplamente documentados na literatura científica e frequentes

na rotina dos serviços de saúde, como a dengue, em que o DSEI Mato Grosso do Sul se destaca como líder nacional em notificações.⁽¹¹⁾

Em 2024, como resposta à necessidade de superar condições que ampliam a vulnerabilidade às doenças negligenciadas, o Governo Federal brasileiro lançou o Programa Brasil Saudável – Unir para Cuidar (PBS), que, entre outras medidas, articula ações que vão além da vigilância, promovendo o cuidado integral e a prevenção, em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).⁽¹²⁾ Entre as premissas do PBS está o incentivo à vigilância ambiental participativa, adaptável ao contexto indígena,⁽¹²⁾ já que todo DSEI conta com um Conselho Distrital de Saúde Indígena (CONDISI), responsável por garantir a participação desses povos na formulação, acompanhamento, fiscalização, avaliação, debate e proposição de políticas voltadas ao fortalecimento da saúde indígena.

Para tanto, o importante trabalho desenvolvido pelos CONDISIs ainda não esgota a participação dos demais setores de vigilância frente a ocorrência de agravos de comportamento sazonal. Nesse sentido, a maior força de trabalho de nível superior na saúde indígena, os enfermeiros, embora com atribuições bem definidas, podem receber demandas adicionais, alterando seus expedientes e fluxos de trabalho, os quais já são mais complexos e desafiadores quando comparados aos de outros serviços da Atenção Primária à Saúde (APS).⁽¹³⁾ Ainda também assumem a função de coordenar o trabalho do Agente Indígena de Saúde (AIS) e em algumas aldeias, também do Agente Indígena de Saneamento (AISAN), profissionais indígenas considerados protagonistas na implementação local das ações previstas pelo PBS.

A partir dessa complexidade do trabalho na saúde indígena em grandes territórios como no DSEI Mato Grosso do Sul, este estudo teve como objetivo avaliar a sazonalidade de agravos negligenciados em saúde e o atendimento a indígenas no estado de Mato Grosso do Sul, com o intuito de subsidiar o planejamento de estratégias de cuidado em enfermagem.

MÉTODOS

Trata-se de estudo ecológico, descritivo e quantitativo, seguindo o *The REporting of studies Conducted using Observational Routinely-collected health Data* (RECORD). Os dados se referem ao DSEI Mato Grosso do Sul. Este é o único DSEI deste estado e possui o maior Polo Base do Brasil. Atendem as etnias indígenas, Guarani, Guarani Kaiowá, Guarani Nhandeva, Guató, Kadiwéu, Kinikinau e Terena.

A amostra foi censitária, englobando todo o universo de indígenas aldeados, seguindo critérios de inclusão e exclusão. Foram incluídos os dados de indígenas assistidos pelo DSEI Mato Grosso do Sul, e excluídos os registros de atendimentos de indígenas na atenção secundária e terciária em saúde.

A coleta de dados foi realizada em abril de 2025, de forma digital, por dois pesquisadores doutores com experiência em pesquisas epidemiológicas, diretamente nos bancos de dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e nas informações disponíveis no Painel de Atendimento do Sistema de Atenção à Saúde Indígena (SIASI) geral e extensão "Atendimentos", utilizando dois filtros padrão: DSEI e Unidade Federativa (UF). Para o levantamento destes dados, foi utilizado um roteiro estruturado, elaborado especificamente para este estudo, com base nas variáveis presentes nas bases, referentes aos últimos três anos (2022, 2023 e 2024), conforme a disponibilidade dos dados.

No Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), foram selecionados quatro agravos de notificação compulsória com ocorrência em territórios indígenas, independentemente da faixa etária e do sexo, e que apresentam comportamentos epidemiológicos sazonais. Nesta etapa, foram excluídas as doenças parasitárias e respiratórias por tratarem de agravos frequentemente estudados no contexto da saúde indígena. Dessa forma, os agravos definidos para análise foram: acidentes por animais peçonhentos (CID-10 – T63), dengue (CID-10 – A90), vírus Zika (CID-10 – A92.5) e febre de chikungunya (CID-10 – A92.0). Ambos os agravos selecionados possuem relação direta com os DSS foco do PBS, os quais exigem ações intersetoriais entre saúde, meio ambiente, educação e saneamento.

Após a extração dos dados nos sistemas, foram construídas planilhas no Microsoft Excel versão 2019, e conferidas por dois pesquisadores de forma independente. Na sequência, realizou-se o agrupamento dos atendimentos por profissional de saúde e gerais no recorte temporal, com cálculo da média de atendimentos; assim como a distribuição dos atendimentos pelos agravos em saúde selecionados. Por meio do *software* SPSS versão 20.0, aplicou-se estatística descritiva, com distribuição de frequências, organizadas em gráficos. Posteriormente, identificou-se quais dos quatro agravos foram mais prevalentes no período (2022-2024), filtrando do banco de dados do SINAN, as variáveis raça/cor indígena e notificação por município de residência. Com o uso do programa Tabwin®, versão 4.13, foram então construídos os mapas.

O estudo respeitou todos os aspectos éticos em pesquisa dessa natureza, baseada em dados público e abertos.

Ainda assim, o projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade do Estado de Mato Grosso (CEP/UNEMAT), sob Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) nº 74789123.2.0000.5166. Para acessar as informações foi consultada a SESAI pela plataforma "Fala.BR" de acordo com o protocolo NUP nº 25072.065059/2024-14.

RESULTADOS

O DSEI Mato Grosso do Sul atende indígenas residentes de 103 aldeias, em 34 terras indígenas e 65 áreas de retomada. No que se refere a cobertura de atendimento nas 79 Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI) e nos 39 pontos de apoio para atendimento, 100% das aldeias recebem atendimentos em saúde pela Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI). Conta com 249 AIS, 154 técnicos de enfermagem, 78 enfermeiros e 58 médicos (38 pelo Programa Mais Médicos, 19 pela Missão Evangélica Caiuá e um pelo Programa Médicos pelo Brasil).

Em 2022, os profissionais AIS (414.758; $\pm 5,18$) e técnicos de enfermagem (177.730; $\pm 2,22$) tiveram maior volume de atendimentos. Essa mesma característica de produção foi apresentada em 2023, porém menor do que o período anterior, 371.066 ($\pm 4,51$) e 161.787 ($\pm 1,97$), respectivamente. Em 2024, observou-se crescimento considerável no volume e média de atendimentos realizados pelos enfermeiros (68.083; $\pm 0,81$), médicos (81.018; $\pm 0,97$) e odontólogos (34.377; $\pm 0,41$), e manutenção de queda nos atendimentos dos AIS (322.425; $\pm 3,84$), psicólogos (5.060; $\pm 0,06$) e assistentes sociais (1.621; $\pm 0,02$) (Figura 1).

Quanto aos atendimentos gerais, o mês de maio se destacou nos dois primeiros anos e abril no final da série histórica. O mês de agosto apresentou menor oscilação ao longo do período (Figura 2).

Em relação a distribuição dos agravos selecionados, o mês de março apresentou mais notificações para febre de chikungunya ($n=394/1.553$; 25,3%) e abril para dengue ($n=312/1.909$; 16,3%). Os meses com menor número de casos (julho a setembro) mantiveram uma média de atendimentos semelhante a outros períodos (Figura 3).

Na Figura 4, verifica-se uma redução de 72,3% nas notificações de dengue no período analisado. No último ano, a distribuição espacial dos casos indicou maior concentração na região Sul do estado.

Na Figura 5, observa-se um aumento nos casos notificados de febre de chikungunya, encerrando com 318 casos, 49,3% superior ao início do período. Ao contrário da dengue, em 2024, houve maior distribuição de casos de febre de chikungunya pelos municípios do estado.

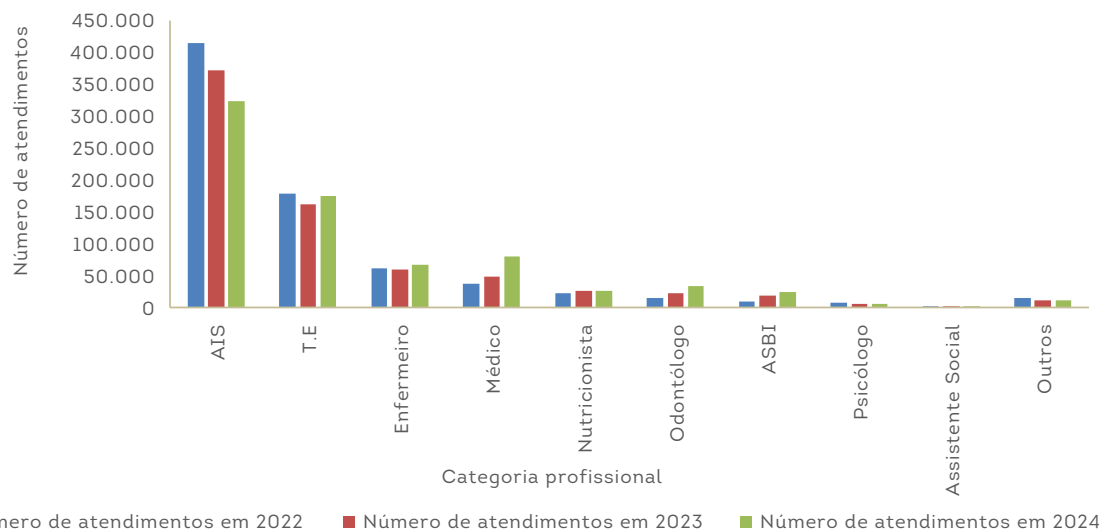


Figura 1. Distribuição de atendimentos por categoria profissional no DSEI Mato Grosso do Sul

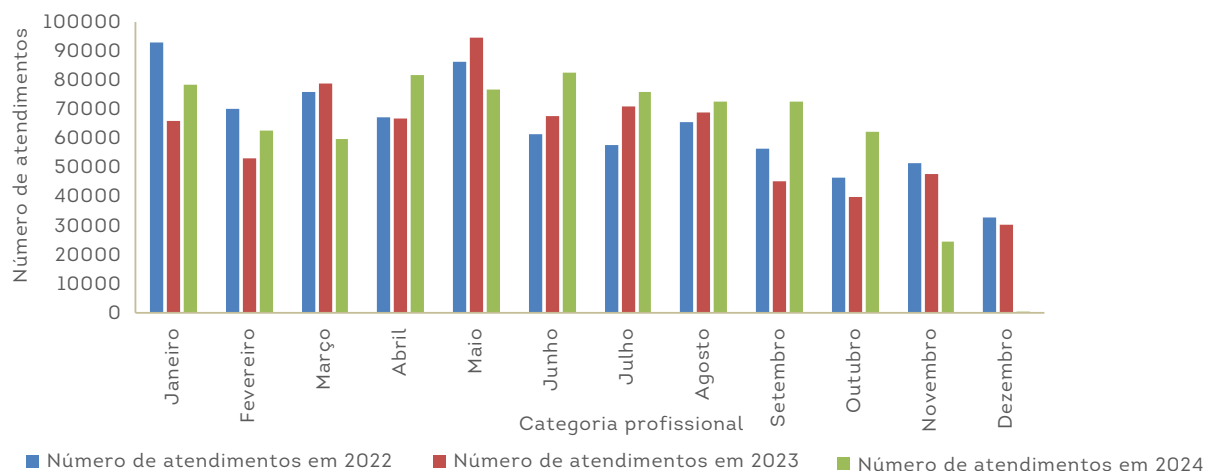


Figura 2. Distribuição de atendimentos dos profissionais por mês, na série histórica

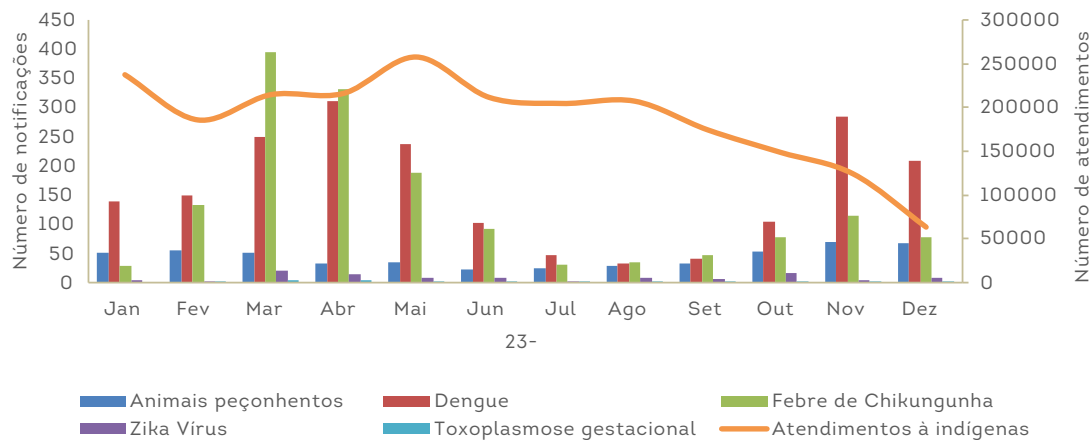


Figura 3. Distribuição de agravos notificados em indígenas em Mato Grosso do Sul, registrados no SINAN e atendimentos dos profissionais de saúde do DSEI Mato Grosso do Sul

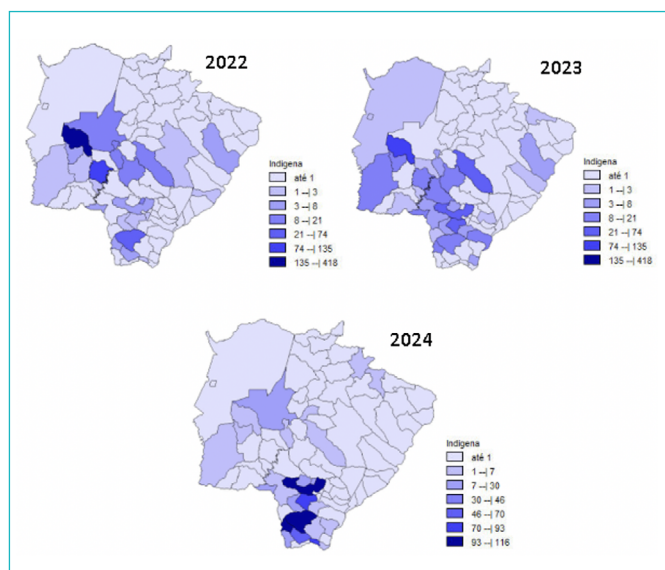


Figura 4. Distribuição de casos notificados de dengue em indígena na série histórica

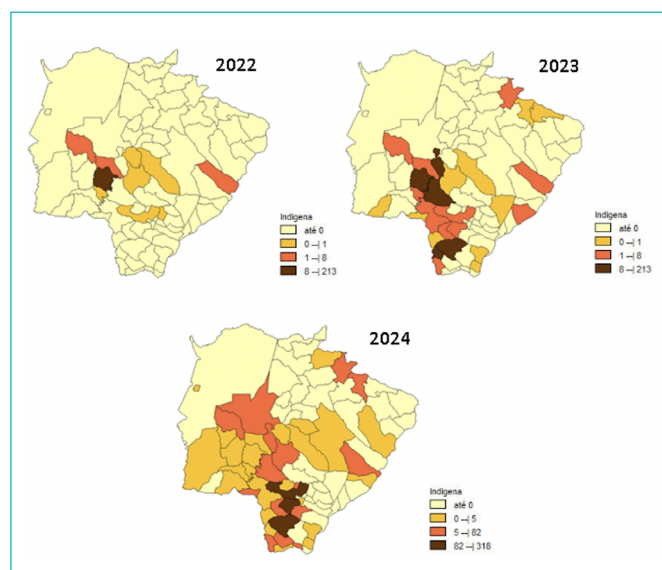


Figura 5. Distribuição de casos notificados de febre de chikungunya em indígena na série histórica

DISCUSSÃO

No estudo, os profissionais AIS tiveram destaque tanto no volume expressivo de atendimentos como pelo decréscimo destes ao longo do período. Antes mesmo da criação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI), esses profissionais, ainda não reconhecidos como uma categoria formal e remunerada, já representavam, em muitas aldeias, o principal meio de comunicação e mediação de problemas de saúde.⁽¹⁴⁾ Com o fortalecimento da PNASPI, esses profissionais passaram a possuir maior visibilidade na saúde indígena, especialmente em regiões remotas e de difícil acesso para os demais integrantes da EMSI.

Tais aspectos impulsionaram a criação de programas de educação permanente em saúde, mas esses ainda enfrentam obstáculos relacionados à garantia de recursos e à ausência de diretrizes nacionais consolidadas e de caráter obrigatório para essa finalidade.⁽¹³⁾ Mudanças positivas podem ocorrer com a regulamentação da profissão, atualmente em tramitação nas comissões da Câmara dos Deputados (Projeto de Lei No. 3.514/2019).⁽¹⁵⁾

Nesse sentido, embora possuam atribuições importantes, muitos AIS não conseguem desenvolver seu processo de trabalho conforme o esperado pelo DSEI, em razão de fatores individuais, como barreiras linguísticas, letramento em saúde, aspectos atitudinais e conflitos de autoridade; e institucionais, como a falta de suporte e de atenção direcionada às dificuldades enfrentadas por esses profissionais.^(16,17) Essas características revelam que, mesmo com a presença dos AIS nos territórios indígenas, eles podem não

estar conseguindo atender plenamente às particularidades epidemiológicas locais. É sabido, contudo, que, independentemente da formação, cada profissional constrói uma percepção singular sobre o próprio exercício profissional e dos desafios.⁽¹⁸⁾

Até o momento, não há estudos conhecidos sobre a realidade dos atendimentos realizados pelos AIS em nível nacional, tampouco em Mato Grosso do Sul, o que exige uma investigação mais aprofundada por meio de estudos *in loco*. Hipoteticamente, a redução de atendimento neste estudo pode estar relacionada à implementação de novas rotinas ou responsabilidades que sobrecarregaram funções já acumuladas; ao crescimento populacional indígena do estado sem a correspondente ampliação da força de trabalho; ou, ainda que menos provável, à substituição de AIS, o que implicaria para o novo profissional indígena, um processo de identificação e adaptação ao trabalho.

O crescimento de atendimentos de enfermeiros desse DSEI em 2024, pode ser um reflexo do movimento crescente de avanço curricular na formação da enfermagem brasileira, com a incorporação de estratégias didático-pedagógicas mais alinhadas à diversidade da população,⁽¹⁹⁾ ao mercado de trabalho, à inovação⁽²⁰⁾ e às necessidades de assistências cada vez mais complexas, incluindo o cuidado aos indígenas.⁽²¹⁾ Além disso, a adesão à teorias de enfermagem em treinamentos e capacitações que considerem e congreguem os aspectos culturais como elementos essenciais para o estabelecimento dos planos de cuidados,⁽²²⁾ de forma inequívoca traz um olhar mais integral, respeitoso e condizente.

Os enfermeiros podem, ainda, estar assumindo atribuições extras em decorrência de vazios assistenciais deixados por outros profissionais da EMSI e de possíveis atividades represadas. Estudo realizado no DSEI Leste, em Roraima, reforça que o enfermeiro atuante na saúde indígena exerce um papel de liderança multifacetado, medianando o equilíbrio das ações executadas.⁽²³⁾ No DSEI Amapá e Norte do Pará, os enfermeiros relataram que o tempo de atuação na função e junto à comunidade amplia o senso de responsabilidade e compromisso com o trabalho de enfermagem.⁽¹⁸⁾ Já para enfermeiros indígenas do DSEI Alto Rio Negro, uma atenção diferenciada ocorre quando a EMSI se desloca até o indígena, e não quando este precisa ir até o atendimento.⁽²⁴⁾

Os atendimentos em saúde nas aldeias também são impactados por fatores ambientais (destino inadequado de lixo na aldeia, desmatamento, queimadas e deslocamento populacional) e climáticos, sendo as arboviroses responsáveis por parte do aumento dessas demandas. Em Mato Grosso do Sul, os meses de calor intenso e chuvas, geralmente entre outubro e abril, concentram a maior parte dos registros de notificações.⁽²⁵⁾ Esse período coincide com os achados do estudo tanto para dengue quanto para febre chikungunya, agravos transmitidos pelo mesmo vetor.

Uma possível explicação para a redução de casos de dengue e o aumento de casos de febre de chikungunya entre os indígenas deste estado, para além das campanhas preventivas, que se aplicam de forma semelhante a ambas as doenças, está relacionada ao fator imunológico. O primeiro caso notificado de dengue no Brasil ocorreu em 1981, com diversos surtos ao longo das décadas, enquanto a chikungunya teve seu primeiro caso autóctone confirmado em território brasileiro apenas em 2014.⁽²⁶⁾ Considerando a existência de quatro sorotipos do vírus da dengue (DENV 1-4), é possível que os indígenas previamente expostos tenham adquirido algum grau de imunidade,⁽²⁷⁾ muitas vezes com poucos ou nenhum sintoma, o que reduz a busca por atendimento e, conseqüentemente, a notificação dos casos (subnotificação de casos leves).

Outros fatores que podem explicar o aumento nos registros de febre de chikungunya incluem a adoção de melhores práticas diagnósticas, que possibilitam a distinção de casos anteriormente confundidos com dengue ou COVID-19;⁽²⁸⁾ o maior empenho da vigilância epidemiológica em municípios fronteiriços com a Bolívia e o Paraguai⁽²⁹⁾ países que há anos enfrentam surtos repetidos de arboviroses; e o avanço na compreensão sobre a co-circulação de arbovírus e a ocorrência de coinfeções.⁽³⁰⁾

A intensidade da febre de chikungunya e seus efeitos prolongados a posicionam como mais grave em comparação à dengue. No entanto, neste estudo, não foi observada, para nenhum dos agravos, uma elevação nos atendimentos realizados pelos profissionais da EMSI nos períodos de maior notificação. Um dos possíveis motivos é que os atendimentos na APS indígena seguem rotinas previamente definidas, com foco prioritário em demandas crônicas e no acompanhamento de pacientes vinculados a programas ministeriais,^(18,23,24) como pré-natal, puericultura e vacinação, o que reduz a flexibilidade para o redirecionamento de esforços durante surtos sazonais.

Os agravos em saúde com comportamentos sazonais, não somente os investigados neste estudo, contribuem para que toda equipe consiga elaborar planejamentos antecipados⁽³¹⁾ e adequados aos recursos disponíveis pelo DSEI. Ressalta-se também que o acesso livre dos dados sobre a ocorrência de agravos em saúde de indígenas pelo SIASI, poderá melhorar a avaliação das estratégias de cuidado implementadas pela SESAI e corrigir inconsistência entre os relatórios de gestão, a realidade dos territórios indígenas e a proporção de investimentos. E considerando que as arboviroses ocorrem com frequência e, muitas vezes, em caráter epidêmico, as abordagens preventivas e educativas da EMSI, quando fundamentadas nesses dados epidemiológicos, podem contribuir significativamente para a concretização das metas do PBS, em especial da Diretriz 2, ao intensificar a atenção a povos e territórios indígenas.

Em outra ótica, a naturalização de agravos em saúde, como pode ser o caso de algum desses investigados no estudo, especialmente quando são considerados sérios, mas comumente não graves, tende a converter cuidados integrais em cuidados inespecíficos, ao se presumir que as práticas de saúde e de autocuidado necessárias à prevenção e ao tratamento adequado já são compreendidas pela comunidade. Nessas situações, o profissional e o serviço de saúde indígena tendem a realizar ações e intervenções pouco alinhadas à história natural da doença e à perspectiva de Saúde Única, fundamentais para o enfrentamento das necessidades da comunidade indígena, especialmente em Mato Grosso do Sul, onde muitos indígenas já não têm como referência ou acesso as UBSIs e aos Polos Base.

Ademais, ao se observar as diferentes categorias profissionais atuantes no DSEI Mato Grosso do Sul, a partir dos dados secundários utilizados, surge uma reflexão, parece que os enfermeiros e outros membros da equipe não estão conseguindo documentar todos os atendimentos realizados, ou continuam priorizando os registros apenas daqueles relacionados a condições de saúde que demandam

retorno ou acompanhamento prolongado, com vistas ao cumprimento de protocolos assistenciais rigorosos. Outra preocupação relevante nesse contexto refere-se ao fenômeno, cada vez mais frequente nas comunidades indígenas, dos depósitos tecnogênicos, que possuem correlação direta com os agravos negligenciados abordados neste estudo.

Essa problemática pode integrar o trabalho do enfermeiro tanto em nível central, junto ao Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Saúde Indígena (DEAMB), quanto em nível regional, no Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental Indígena (SESANI), setores que ainda contam com pouca atuação de profissionais de enfermagem.

Possíveis distorções dessa natureza podem, a médio e longo prazo, gerar questionamentos e cobranças que marquem situações de violências e abusos perante às atribuições do enfermeiro, mesmo que, em alguns casos, esse comportamento de gestores e de algumas lideranças da própria comunidade indígena esteja em desacordo com a legislação profissional vigente, o que é uma circunstância recorrente na saúde indígena brasileira. Além disso, essa situação pode contribuir para a equivocada percepção, de que os problemas da saúde indígena são simples, autolimitados e se resolvem sem a presença de uma equipe completa, integrada e com condições de trabalho favoráveis.

As limitações do estudo estão relacionadas às características dos dados secundários e dos sistemas de informação utilizados, que não permitem a diferenciação entre as etnias indígenas, entre os tipos de atendimentos por agravo (clínicos e não clínicos) e durante os meses; nem a duração, local (aldeia ou cidade) e a frequência de atendimentos por indígena e agravo. Contudo, este é o primeiro estudo que apresenta uma aproximação entre características do trabalho em saúde indígena e a demanda de atendimentos, considerando uma série histórica e anual de agravos.

O estudo oferece subsídios importantes para o planejamento e reorganização das estratégias de cuidado em enfermagem na atenção à saúde indígena, evidenciando que os atendimentos mantêm padrão linear mesmo diante

de agravos sazonais. Isso sinaliza a necessidade de maior flexibilidade no processo de trabalho das equipes, especialmente em contextos de surtos epidêmicos, além de indicar o potencial uso de intervenções digitais em saúde para apoiar a atuação dos profissionais e agentes indígenas de saúde.

CONCLUSÃO

A sazonalidade dos agravos investigados não influenciou diretamente o volume de atendimentos dos profissionais de saúde, ainda que tenha observado o crescimento entre algumas categorias, sugerindo que a atuação destes ocorre predominantemente em uma dinâmica linear, podendo ser um risco diante de surtos epidêmicos. Não obstante, esse processo de trabalho precisa ser repensado para verificar se consegue atender as demandas dos indígenas, enquanto necessidades em saúde, ou se vem se estabelecendo nos moldes de práticas que visam unicamente suprir relatórios. Os enfermeiros podem utilizar ferramentas que estão sob seu domínio diário, e que, nos últimos anos, também passaram a fazer parte do cotidiano dos indígenas de Mato Grosso do Sul, como os *smartphones* e o acesso à internet, para realizar Intervenções Digitais em Saúde (IDS), as quais potencializam seu trabalho e auxiliam os AIS e AISAN na dinamização e no direcionamento de suas práticas assistenciais no território.

Para ampliar esse entendimento, novos estudos devem ser conduzidos a fim de evidenciar quais são os obstáculos no contexto desse DSEI que fragilizam ou impedem a participação efetiva da equipe e as formas de responder estrategicamente aos agravos em saúde do cotidiano indígena.

Contribuições

Concepção e/ou desenho do estudo: Nascimento VF, Oliveira SV; Coleta, análise e interpretação dos dados: Nascimento VF, Oliveira SV; Redação e/ou revisão crítica do manuscrito: Oliveira NR, Nascimento VF, Marinho GL, Martins MS, Lourenção LG; Aprovação da versão final a ser publicada: Nascimento VF, Oliveira SV, Marinho GL, Martins MS, Lourenção LG.

REFERÊNCIAS

1. Ministério da Saúde. População Indígena: SESAI. 2025 [cited 2025 Apr 14]. Available from: https://infoms.saude.gov.br/extensions/sesai_pop_indigena/sesai_pop_indigena.html
2. Casagrande F, Luz VG, Martins CP, Dias-Scopel RP, Fernandes R, Fonseca W. A saúde indígena na atenção especializada: perspectiva dos profissionais de saúde em um hospital de referência no Mato Grosso do Sul, Brasil. *Cad Saúde Pública*. 2024;40(6):e00094622.
3. De Pinho A, Calheiros DF, Almeida FS, Zerlotti P, Cereali M, Feiden A, et al. Agrotóxicos e violações nos direitos à saúde e à soberania alimentar em comunidades Guarani Kaiowá de MS, Brasil. *Ciênc Saúde Coletiva*. 2024;29(12):e06462024.
4. Ferreira PS, Silva CA. Análise dos impactos socioambientais na reserva indígena de Dourados, Mato Grosso do Sul. *Rev Pantaneira*. 2024;25(23):108-18.

5. Campos AR, Alfama GF, Barbosa CC. Determinantes da vulnerabilidade em saúde dos povos indígenas no contexto da pandemia de COVID-19: uma revisão integrativa da literatura. *Braz J Health Rev.* 2022;5(2):6642-53.
6. Silva PF, Almeida BC, Menezes E, Vasconcelos LC, Machado RR, Machado DA. Processo de construção do Programa Nacional de Acesso à Água Potável em Terras Indígenas (PNATI). *J Health NPEPS.* 2022;7(2):e10618.
7. Cunha ML, Casanova AO, Cruz MM, Suárez-Mutis MC, Marchon-Silva V, Souza MS, et al. Planejamento e gestão do processo de trabalho em saúde: avanços e limites no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do SUS. *Saúde Soc.* 2023;32(3):e220127pt.
8. Pinto DF, Ribeiro AM. Alocação orçamentária e o desempenho: análise dos critérios de distribuição orçamentária das unidades da SESAI/MS. *Rev Gestão Sec.* 2023;14(7):11268-93.
9. Moraes J. T. O subsistema de atenção à saúde indígena e sua efetivação no estado de Mato Grosso Sul: análise no funcionamento, ações e serviços. *Rev Juris UniToledo.* 2023;3(04):191-203.
10. Reis LA, Almeida Filho RA. Vulnerabilidade social em Mato Grosso do Sul: um panorama das desigualdades e políticas de intervenção. *Multitemas.* 2025;30(esp):43-9.
11. Oliveira VJ, Borges RV, Gomes WR, Oliveira BS, Silva MV, Fonseca SL, et al. Epidemiologic characterization of cases of arbovirolosis transmitted by mosquitoes of the genus *Aedes* reported in indigenous Brazilians. *Peer Rev.* 2023;5(14):166-78.
12. Sob liderança brasileira, BRICS propõe Parceria Global para eliminar doenças ligadas às desigualdades. 2025 [cited 2025 Apr 24]. Available from: <https://brics.br/pt-br/noticias/sob-lideranca-brasileira-brics-propoe-parceria-global-para-eliminar-doencas-ligadas-as-desigualdades>
13. Vicente RM, Moreira NF, Moreira CC, Simonelli CG, Luz VG. Condições de trabalho dos profissionais de saúde indígena no maior Polo Base do Brasil. *Cad Saúde Pública.* 2022;38(12):e00110321.
14. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2002.
15. Projeto de Lei No. 3.514, de 13 de junho de 2019. Regulamenta a profissão de Agente Indígena de Saúde (AIS) e Agente Indígena de Saneamento (AISAN), no âmbito do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), e dá outras providências. Autoria Joenia Wapichana. 2019 [cited 2025 Apr 14]. Available from: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2207982>
16. Oliveira AC, Paes AS, Silva LR. Saúde indígena no DSEI médio rio Purus, Amazonas: os desafios na provisão de um serviço equânime. *Rev Interface.* 2022;19(esp):31-53.
17. Monteiro CG, Rezende RC, Santos VL, Gomes SR, Silva DM, Pinto DS. Programa de qualificação dos agentes indígenas de saúde (AIS) e agentes indígenas de saneamento (AISAN): análise do processo educacional com espacialização de qualificação, no contexto Intercultural, na Fazenda Experimental da UFAM, no Amazonas. *BIUS.* 2020;23(17):1-27.
18. Mendes AM, Pedrosa NC, Rocha GS, Silva RA, Ibiapina AR, Jenajaque OJ. Atuação profissional e as competências culturais necessárias para o trabalho na Saúde Indígena. *rLAS.* 2024;6(1):1-21.
19. Castro NJ, Paes FT, Way JR, Ribeiro NL, Sena ML, Naka KS, et al. Mapeamento dos cursos de enfermagem e interfaces com a inclusão de estudantes indígenas. *Texto Contexto - Enferm.* 2024;33:e20240084.
20. Silva MM, Thiago TA, Baixinho CR, Cruchinho PJ, Rossi BM, Silva IR, et al. Inovação nas estratégias organizacionais e de ensino de graduação/pós-graduação em enfermagem: uma abordagem qualitativa. *Rev Bras Enferm.* 2025;78(2):e20240278.
21. Nascimento VF, Hattori TY, Terças-Tretteç AC. Desafios na formação de enfermeiros indígenas em Mato Grosso, Brasil. *Ciênc Saúde Coletiva.* 2019;25(1):47-56.
22. Aydogdu AL. Enfermagem transcultural: um desafio na formação em enfermagem. *J Health NPEPS.* 2022;7(1):e6013.
23. Soares DC. A importância do enfermeiro na assistência à saúde dos povos indígenas do DSEI/Leste-RR. *Asclepius Int J Sci Health Sci.* 2025;4(5):43-53.
24. Feitosa MR, Pontes AL. Os sentidos da atenção diferenciada para os profissionais de saúde no DSEI Alto Rio Negro-AM, Brasil. *Ciênc Saúde Coletiva.* 2024;29(12):e07052024.
25. Gonzaga DM, Klener J, Goldfinger AP, Barbosa KF, Vanzela LS, Vazquez GH, et al. Perfil ecoepidemiológico das arboviroses Dengue, Zika e Chikungunya no estado de Mato Grosso do Sul, de 2015 a 2021. *Rev Cient Esc Estadual Saúde Pública Goiás "Cândido Santiago".* 2024;10(10a0):1-27.
26. Donalísio MR, Freitas AR, Von Zuben AP. Arboviroses emergentes no Brasil: desafios para a clínica e implicações para a saúde pública. *Rev Saúde Pública.* 2017;51:30.
27. Medeiros EA. Desafios no controle da epidemia da dengue no Brasil. *Acta Paul Enferm.* 2024;37:eEDT012.
28. Silva CC, Silva AC, Lima CL, Santana MA, Gomes JC, Moreno GM, et al. Diagnóstico da chikungunya por inteligência artificial e dados de prontuários. *J Health Inform.* 2024;16(esp):1-15.
29. Costa SE, Costa EA. Análise da implantação do Programa Nacional de Controle da Dengue: estudo comparativo de municípios fronteiriços de Mato Grosso do Sul (Brasil). *Cuad Geogr Rev Colomb Geogr.* 2020;29(2):310-32.
30. Gonçalves FJ, Negreiros GF, Silva MC, Cunha RG, Santos RA. Chikungunya: análise epidemiológica do vírus chikungunya no Piauí. *Rev Piauiense Enferm.* 2025;1(2):1-13.
31. Lima VV, Peres WP, Oliveira Júnior JS, Arcoverde MA, Arcêncio RA, Vitorino FR, et al. American tegumentary leishmaniasis: spatial analysis to identify high-risk areas in the state of Mato Grosso. *J Health NPEPS.* 2025;10(1):e13442.